

24.4 Imc

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

NEIDE SOARES YAMAMOTO

IDADE: 61 PESO: 46 ALTURA: 165 PROFISSÃO: Assist. Social - Apos
SINTOMAS: Sonolência / taquicardia à noite / Zumbido
QUEIXAS: cansaço / falta de energia / acorda engasgada
MEDICAMENTOS: Losartema / Eski (depressão)
PA - Labirintite / Depressão (ps-parto)

MÉDICO: Dr. Mariana

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não pode no momento devido deterioração.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (19:30)

HORA QUE DORME: 21h HORA QUE ACORDA: 8 - 8:30

COCHILHO ☒ SIM () NÃO 2h DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO ☒ EVENTUALBEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃOFUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 5x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: curto

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 50 e/h

SPO2: 78%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hérnia de hiato (refluxo) / nervo ciático

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Não

IMC: 24.4

artrose quadril e tornozelo

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS escoliose lombar/dorsal

28/06/24 Avaliação - Orçamento Philips e máscara prom.

15/07/24 P= 8.8 cmH₂O bolson de face.

IAH= 3.9 e/h

fuga = 5"

m. de uso: 6h 35'

Jua claudia

19/08/24 P= 8.7 cmH₂O

Bem adaptado

IAH= 4.4 e/h

m. de uso: 9h 20'

Fuga= 12'

Jua.

26/09/24 P= 9.0 cmH₂O

IAH= 7.0

m. de uso: 8:46'

- estava a fuga de ar pela máscara. - Jua
- teve sintoma forte.18/11/24 P= 7.8 cmH₂OP90%= 9.0 cmH₂O

IAH= 7.8 e/h

m. de uso: 8h 39 min

fuga= 0

A P: 5 à 10 cmH₂O

Silvia

20/02 P = 8,8 cmH₂O
25 IAH = 7.9 e/ev
M. de uso: 8h 25'

P o peso.

uma clonidia

Auto 6 à 10 cmH₂O

15/05/25 P = 9,3 cmH₂O P90% = 10,0 cmH₂O

IAH = 6,6 e/ev

muvo = 9h30 min

fuja = 0 kg.

vai fazer colono,
duis melano

Silvia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: NEIDE SOARES YAMAMOTO			
Sexo: F	Idade: 61 anos	Peso: 64 Kg	Altura: 1,62 m
IMC: 24,4	Data do Exame: 18/04/2024	Exame: 13391_01	
Médico solicitante: DRA MARIANA			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:40:40 horas e encerrado às 06:01:02 horas, com latência para o sono de 43 minutos e latência para o sono REM de 55 minutos. O tempo total de sono foi de 273,5 minutos, com eficiência do sono de 82,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	5,7%	Até 5%
Estágio 2	70,0%	45 - 55%
Estágio 3	3,1%	> 15%
Sono REM	21,2%	20 - 25%
Eficiência do sono	82,2%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 122,5 minutos ocorreram 119 despertares (índice de 25,1/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 66 bpm, a maior de 81 bpm e a menor de 58 bpm. Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.

Ocorreram 228 eventos respiratórios, sendo 0 central e 228 obstrutivos. Sendo 190 apnéias, 38 hipopnéias e 0 RERAS. O Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 50,0/hora, sendo 41,7 apnéia/hora e 8,3 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17,3 e a duração máxima de 28,6.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 66,2/hora, sendo 60,0 apnéia/hora e 6,2 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 92%, a maior de 98% e a mínima de 78%, permanecendo 16,9 minutos (3,9%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 169 dessaturações. Índice de dessaturações: 37,1/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 58,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 32,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264